



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

**PEDOMAN KERJA
KOMITE TENAGA KESEHATAN LAIN
RS PRIMA HUSADA
TAHUN 2025**

Jl. Raya Surabaya - Malang No. KM 54, Sukorejo - Pasuruan

Telp. 0343 - 6745000

Email : sekretariat@sukorejo.rs-primahusada.com

www.rs-primahusada.com



Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada
Nomor 004.3/RSPHS/I-PER/DIR/I/2025

Tentang
Pedoman Kerja Komite Tenaga Kesehatan Lain

Penanggung Jawab

(Elza Safarina Ulfa, Amd.AK)

Disetujui Oleh :
Authorized Person

(Dr. dr. Aslichah, M.Kes, AFP)

Ditetapkan Oleh :
Direktur Rumah Sakit Prima Husada



(Ns. Heni Indra Wulansari, S.Kep.Ns., M.Kep)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya Pedoman Kerja Komite Tenaga Kesehatan Lain (KTKL) Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo ini dapat disusun dengan baik.

Komite Tenaga Kesehatan Lain merupakan wadah non-struktural di rumah sakit yang memiliki peran strategis dalam menjaga dan meningkatkan profesionalisme para tenaga kesehatan penunjang medik yang meliputi Tenaga Teknis Kefarmasian/Apoteker, Radiografer, Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM), Tenaga Gizi (Dietisien/Nutrisionis), Perkam Medis (RMK), serta Fisioterapis melalui mekanisme kredensial, pembinaan mutu profesi, serta penegakan etika dan disiplin profesi. Pedoman kerja ini disusun sebagai acuan resmi bagi Komite Tenaga Kesehatan Lain dalam melaksanakan tugas dan fungsi secara terarah, terkoordinasi, dan berkelanjutan.

Pedoman kerja ini memuat ketentuan mengenai struktur organisasi, tugas dan fungsi komite, serta mekanisme kerja yang meliputi kegiatan Subkomite Kredensial, Subkomite Mutu Profesi, dan Subkomite Etik serta Disiplin Profesi. Dengan adanya pedoman ini, diharapkan seluruh program dan kegiatan internal Komite Tenaga Kesehatan Lain dapat berjalan secara efektif dalam mendukung peningkatan mutu pelayanan penunjang dan keselamatan pasien di rumah sakit.

Penyusunan pedoman ini juga merupakan bentuk implementasi nyata dari regulasi nasional yang berlaku, termasuk Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, serta sebagai upaya pemenuhan Standar Akreditasi Rumah Sakit Kementerian Kesehatan (STARKES) dalam rangka peningkatan mutu pelayanan kesehatan secara berkelanjutan di RS Prima Husada Sukorejo.

Malang, 1 Januari 2026
Direktur RS Prima Husada



Ns. Heni Indra Wulansari, S.Kep.,M.Kep

TIM PENYUSUN

1. Elza Safarina Ulfa, Amd.
2. Nurul Kamilia, S.Tr.RMIK
3. Fina Fitriana Dwi Nur Hayati, Amd. RMIK
4. Adinda Riza Febrianti., Amd, Rad
5. Saila Nur Siti Khodijah, S. Gz.
6. Nikmatul Khoiria, Amd. Kes
7. Laili Choirul Umma, S.Farm.,Apt
8. Ayu Indra Irmia, Amd.Farm.
9. Hesty Putri Wulandari, S.Tr.Kes
10. Ramadhan Rizki Putranto., S.Farm,. Apt
11. Amirul Rosyidin, A.Md.RMIK

DAFTAR ISI

SAMPUL.....	i
PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
TIM PENYUSUN	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vi
PERATURAN DIREKTUR	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	2
1.4 Ruang Lingkup.....	2
1.5 Batasan Operasional.....	2
BAB II STANDAR KETENAGAAN	4
2.1 Kualifikasi Sumber Daya Manusia.....	4
2.2 Distribusi Ketenagaan.....	4
2.3 Struktur Organisasi Komite Tenaga Kesehatan Lain.....	5
2.4 Uraian Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang.....	5
BAB III STANDAR FASILITAS.....	9
3.1 Denah Ruangan.....	9
3.2 Standar Fasilitas	9
BAB IV TATALAKSANA PELAYANAN.....	10
4.1 Proses Kredensial.....	10
4.2 Diskusi Refleksi Kasus.....	12
4.3 Audit Tenaga Kesehatan Lain dan Kebidanan	13
4.4 Pemberian Tindakan Disiplin	15
4.5 Mekanisme Kerja	16
BAB V HUBUNGAN KERJA.....	18
5.1 Prinsip Umum	18
5.2 Mekanisme Hubungan Kerja	18
BAB VI LOGISTIK.....	19
BAB VII KESELAMATAN PASIEN	20
BAB VIII KESELAMATAN KERJA.....	21
BAB IX PENGENDALIAN MUTU	22
BAB X PENUTUP.....	23

DAFTAR TABEL

Tabel 3.2.1	Standar Fasilitas Ruang Komite Tenaga Kesehatan Lain	9
Tabel 4.1.1	Prosedur Kredensial Perawat	10
Tabel 4.2.1	Tatalaksana Diskusi Refleksi Kasus	12
Tabel 4.3.1	Tatalaksana Audit Tenaga Kesehatan Lain dan Kebidanan	13
Tabel 4.4.1	Tatalaksana Pemberian Tindakan Disiplin.....	15

PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA
NOMOR : 004.3/RSPHS/I-PER/DIR/I/2025

TENTANG

PEDOMAN KERJA KOMITE TENAGA KESEHATAN LAIN

DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan profesionalisme, mutu pelayanan penunjang medis, serta menjamin keselamatan pasien, diperlukan wadah non-struktural yang mengatur tata kelola klinis Tenaga Kesehatan Lain;
- b. bahwa agar Komite Tenaga Kesehatan Lain dapat menjalankan tugas, fungsi, dan wewenangnya dalam hal kredensial, penjagaan mutu profesi, serta penegakan etik dan disiplin secara optimal, diperlukan adanya Pedoman Kerja yang baku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada tentang Pedoman Kerja Komite Tenaga Kesehatan Lain.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Fisioterapi;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Perekam Medis;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Tenaga Gizi;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016 tentang Registrasi dan Praktik Tenaga Kefarmasian;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pelayanan Radiologi Klinik;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2015 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Akreditasi Rumah Sakit;
9. Kepdirjen Yankes Nomor HK.02.02.D.43961.2024 tentang Pedoman Survei Akreditasi Rumah Sakit;
10. Keputusan Direktur Perseroan Terbatas Disa Prima Medika Nomor 1110/DPM/I-KEP/DIR/XI/2025 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA TENTANG
PEDOMAN KERJA KOMITE TENAGA KESEHATAN LAIN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Pengertian

Dalam Pedoman Kerja Komite Tenaga Kesehatan Lain ini, yang dimaksud dengan:

- (1) Komite Tenaga Kesehatan Lain (KTKL) adalah wadah non-struktural rumah sakit yang mempunyai fungsi utama mempertahankan dan meningkatkan profesionalisme staf fungsional penunjang medis melalui mekanisme kredensial, penjaminan mutu profesi, dan pemeliharaan etika dan disiplin profesi;
- (2) Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat;
- (3) Kewenangan Klinis (Clinical Privilege) adalah uraian intervensi dan tindakan spesifik yang dilakukan oleh masing-masing rumpun Tenaga Kesehatan Lain berdasarkan area praktik, kompetensi, dan standar profesinya;
- (4) Penugasan Klinis (Clinical Appointment) adalah penugasan Direktur Rumah Sakit kepada Tenaga Kesehatan Lain untuk melakukan praktik atau pelayanan penunjang medis di Rumah Sakit tersebut berdasarkan daftar Kewenangan Klinis yang telah disetujui;
- (5) Kredensial adalah proses evaluasi terhadap Tenaga Kesehatan Lain untuk menentukan kelayakan pemberian Kewenangan Klinis;
- (6) Rekredensial adalah proses re-evaluasi terhadap Tenaga Kesehatan Lain yang telah memiliki Kewenangan Klinis untuk menentukan kelayakan perpanjangan atau perubahan Kewenangan Klinis tersebut;
- (7) Tenaga Kesehatan Lain adalah pegawai rumah sakit di luar profesi medis dan Tenaga Kesehatan Lain yang meliputi Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM), Apoteker, Tenaga Teknis Kefarmasian (TTK), Radiografer, Tenaga Gizi (Nutrisisionis/Dietisien), Perkam Medis dan Informasi Kesehatan (PMIK), serta Fisioterapis;
- (8) Mutu Profesi adalah kesesuaian perilaku asuhan dan tindakan teknis penunjang medis yang dilakukan staf dengan standar profesi, standar pelayanan, dan perkembangan ilmu pengetahuan terbaru;
- (9) Disiplin Profesi adalah kepatuhan staf Tenaga Kesehatan Lain terhadap aturan, regulasi internal rumah sakit, serta kode etik masing-masing rumpun profesi.

BAB II PENGORGANISASIAN

Pasal 2

- (1) Komite Tenaga Kesehatan Lain berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Rumah Sakit;
- (2) Komite Tenaga Kesehatan Lain merupakan organisasi non-struktural yang dibentuk di Rumah Sakit yang keanggotaannya terdiri dari Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM), Apoteker, Tenaga Teknis Kefarmasian (TTK), Radiografer, Tenaga Gizi (Nutrisionis/Dietisien), Perkam Medis dan Informasi Kesehatan (PMIK), serta Fisioterapis;
- (3) Susunan organisasi Komite Tenaga Kesehatan Lain terdiri dari:
 - a. Ketua Komite Tenaga Kesehatan Lain;
 - b. Sekretaris Komite Tenaga Kesehatan Lain; dan
 - c. Subkomite Kredensial, Subkomite Mutu Profesi, serta Subkomite Etik dan Disiplin Profesi;
- (4) Keanggotaan Komite Tenaga Kesehatan Lain ditetapkan oleh Direktur Rumah Sakit dengan mempertimbangkan sikap profesional, kompetensi, pengalaman kerja, reputasi, dan perilaku;
- (5) Ketua Komite Tenaga Kesehatan Lain ditetapkan oleh Direktur Rumah Sakit dengan memperhatikan masukan dari tenaga kesehatan lain yang bekerja di Rumah Sakit;
- (5) Sekretaris Komite Tenaga Kesehatan Lain dan Ketua Subkomite ditetapkan oleh Direktur Rumah Sakit berdasarkan rekomendasi dari Ketua Komite Tenaga Kesehatan Lain dengan memperhatikan masukan dari tenaga kesehatan lain yang bekerja di Rumah Sakit.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

Komite Tenaga Kesehatan Lain mempunyai tugas meningkatkan mutu pelayanan penunjang medis dan memastikan keselamatan pasien dengan cara:

- (1) Menyelenggarakan kredensial dan rekredensial bagi seluruh Tenaga Kesehatan Lain;
- (2) Memelihara mutu profesi melalui audit kelayakan klinis dan pengembangan keprofesian berkelanjutan;
- (3) Menegakkan disiplin, etika, dan perilaku profesi di lingkungan rumah sakit.

BAB IV TATA LAKSANA PELAYANAN

Pasal 4

- (1) Dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, Komite Tenaga Kesehatan Lain dibantu oleh Subkomite;
- (2) Masing-masing subkomite mempunyai mekanisme dan kewenangan yang jelas untuk mendukung pelaksanaan fungsi Komite Tenaga Kesehatan Lain secara profesional dan akuntabel;
- (3) Subkomite bekerja secara koordinatif di bawah Ketua Komite Tenaga Kesehatan Lain dan bertanggung jawab kepada Direktur Rumah Sakit melalui Ketua Komite Tenaga Kesehatan Lain;

- (4) Pelaksanaan tugas Subkomite dilakukan secara independen, objektif, dan terdokumentasi.

Pasal 5

- (1) Subkomite Kredensial bertugas menyelenggarakan proses kredensial dan rekredensial terhadap seluruh Tenaga Kesehatan Lain yang bekerja di Rumah Sakit;
- (2) Subkomite Kredensial wajib melakukan pemetaan kompetensi, pemeriksaan berkas syarat profesi, wawancara/uji komparatif, serta memberikan rekomendasi tertulis mengenai Kewenangan Klinis kepada Ketua Komite untuk diteruskan kepada Direktur; (Melengkapi kalimat yang menggantung)
- (3) Proses kredensial dilakukan dengan prinsip objektivitas, transparansi, kesetaraan, serta sesuai standar kompetensi dan regulasi yang berlaku.

Pasal 6

- (1) Subkomite Mutu Profesi bertugas menjaga dan meningkatkan mutu pelayanan setiap rumpun profesi melalui evaluasi, audit klinis penunjang, dan pembinaan profesional berkelanjutan;
- (2) Subkomite Mutu Profesi bekerja secara terstruktur dan terjadwal untuk memastikan tercapainya standar mutu pelayanan sesuai regulasi dan akreditasi;
- (3) Penjagaan mutu profesi dilaksanakan dengan pendekatan non-punitif (non-punitive), berorientasi pada pembelajaran dan perbaikan pelayanan berkelanjutan.

Pasal 7

- (1) Subkomite Etik dan Disiplin Profesi bertugas menangani permasalahan etik dan disiplin profesi, serta memberikan rekomendasi pembinaan kepada pimpinan rumah sakit;
- (2) Dalam hal pelanggaran berat atau yang memerlukan kewenangan profesi lebih lanjut, subkomite dapat merekomendasikan pelimpahan kepada bagian SDM sesuai peraturan yang berlaku;
- (3) Hasil pembinaan etik dan disiplin dijadikan bahan evaluasi mutu dan perbaikan sistem kerja Tenaga Kesehatan Lain di rumah sakit.

BAB V
PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasuruan
Pada tanggal 1 Januari 2026
Direktur Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo

Ns.Heni Indra Wulansari, S.Kep.,M.Kep

LAMPIRAN
PERATURAN DIREKTUR RUMAH
SAKIT PRIMA HUSADA SUKOREJO
NOMOR 004.3/RSPHS/I-PER/DIR/I/2025
TENTANG PEDOMAN KERJA KOMITE
TENAGA KESEHATAN LAIN

PEDOMAN KERJA KOMITE TENAGA KESEHATAN LAIN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Pelayanan kesehatan di Rumah Sakit terdiri dari berbagai jenis pelayanan fungsional seperti pelayanan medik, Tenaga Kesehatan Lain, dan pelayanan penunjang medik yang diberikan kepada pasien dalam bentuk upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.

Penyelenggaraan pelayanan penunjang medis di Rumah Sakit ditentukan oleh tiga komponen utama, yaitu jenis pelayanan diagnostik dan terapeutik yang diberikan, sumber daya manusia Tenaga Kesehatan Lain (KTKL) sebagai pemberi asuhan teknis, serta manajemen sebagai tata kelola pemberian pelayanan.

Tenaga Kesehatan Lain di Rumah Sakit yang meliputi Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM), Apoteker, Tenaga Teknis Kefarmasian (TTK), Radiografer, Tenaga Gizi (Nutrisionis/Dietisien), Perekam Medis dan Informasi Kesehatan (PMIK), serta Fisioterapis merupakan pilar penting yang menentukan ketepatan diagnosis, efikasi terapi sediaan obat, intervensi nutrisi, legalitas dokumentasi rekam medis, hingga pemulihan fungsi fisik dan gerak pasien. Setiap rumpun profesi ini memiliki tanggung jawab dan tanggung gugat sesuai kewenangan fungsionalnya dalam memberikan pelayanan yang aman, presisi, dan akuntabel kepada pasien.

Diperlukan Tenaga Kesehatan Lain yang kompeten, mampu berpikir kritis, adaptif terhadap perkembangan teknologi kesehatan, serta senantiasa menjunjung tinggi etika profesi agar pelayanan penunjang medis dapat diberikan dengan mutu terbaik demi mendukung keselamatan pasien.

Dalam aktivitas pelayanan Tenaga Kesehatan Lain, dikenal tindakan yang bersifat mandiri profesional dan tindakan kolaboratif. Tindakan mandiri merupakan kompetensi utama dari masing-masing standar profesi KTKL yang diperoleh melalui pendidikan resmi dan pelatihan berkelanjutan. Tindakan ini menjadi wewenang melekat dan tanggung jawab penuh dari nakes yang bersangkutan.

Sedangkan pengoperasian alat-alat medis berisiko tinggi (seperti CT-Scan/X-Ray di Radiologi), analisis spesimen kritis di Laboratorium, penyiapan obat sitostatika/racikan di Farmasi, pencatatan rekam medis sensitif, asuhan diet pasien berisiko tinggi, serta pemberian modalitas terapi fisik dan program rehabilitasi fungsional berisiko pada pasien dengan kondisi medis kompleks (di Fisioterapi) memerlukan Kewenangan Klinis tertentu yang harus tervalidasi melalui proses kredensial.

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan adanya Pedoman Kerja Komite Tenaga Kesehatan Lain (KTKL) sebagai payung hukum internal agar dapat diimplementasikan, berkontribusi meningkatkan tata kelola klinis yang baik, serta menjamin kualitas kompetensi para staf penunjang di RS Prima Husada Sukorejo.

1.2 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Fisioterapi;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kerja dan Praktik Perekam Medis;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Tenaga Gizi;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 88 Tahun 2014 tentang Registrasi dan Praktik Tenaga Kefarmasian;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pelayanan Radiologi Klinik;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2015 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Akreditasi Rumah Sakit (Standar Akreditasi Kemenkes / STARKES).

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud
Maksud disusunnya Pedoman Kerja Komite Tenaga Kesehatan Lain ini adalah sebagai acuan resmi bagi pengurus komite dalam melakukan pengelolaan, pembinaan, pengawasan, dan pengembangan mutu profesionalisme seluruh staf penunjang medis di RS Prima Husada.
2. Tujuan
 - a. Menjamin terselenggaranya pelayanan penunjang medis yang profesional, etis, aman, dan bermutu tinggi.
 - b. Menyelenggarakan mekanisme kredensial, rekredensial, audit mutu profesi, serta penegakan disiplin perilaku nakes penunjang.
 - c. Mendukung pemenuhan standar akreditasi rumah sakit (STARKES) pada aspek tata kelola kualifikasi dan pendidikan staf (KPS).
 - d. Memberikan perlindungan hukum kepada pasien selaku penerima layanan, Tenaga Kesehatan Lain selaku praktisi, dan rumah sakit selaku institusi penyedia fasilitas.

1.4 Ruang Lingkup

1. Komite Tenaga Kesehatan Lain merupakan wadah non-struktural kelompok profesi penunjang medis yang secara struktural fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Rumah Sakit.
2. Komite Tenaga Kesehatan Lain bekerja sama dan melakukan koordinasi lintas struktural dengan para Kepala Instalasi (Farmasi, Laboratorium, Radiologi, Gizi, Rekam Medis, dan Fisioterapi/Rehab Medik) serta saling memberikan masukan tentang perkembangan ilmu dan teknologi penunjang klinis di rumah sakit.
3. Komite Tenaga Kesehatan Lain mempunyai fungsi utama mempertahankan dan meningkatkan profesionalisme staf penunjang melalui optimalisasi tiga pilar kerja: Sub Komite Kredensial, Sub Komite Mutu Profesi, dan Sub Komite Etik & Disiplin Profesi.

4. Komite Tenaga Kesehatan Lain bertindak sebagai mitra strategis manajemen rumah sakit dalam merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan keselamatan pelayanan penunjang klinis.

1.5 Batasan Operasional

1. Fungsi komite tenaga kesehatan lain dalam kaitan dengan Manajemen dan instalasi Penunjang
 - a. Mengedepankan hubungan kemitraan, koordinasi, kolaborasi, dan saling menguatkan, bukan hubungan struktural atasan-bawahan.
 - b. Menjadi media utama untuk mengakomodasi dan memfasilitasi kebutuhan pengembangan profesionalisme (CPD) nakes penunjang demi menjaga mutu layanan.
 - c. Membantu fungsi manajemen dalam menyelesaikan persoalan operasional mutu klinis di lapangan.
 - d. Memberikan rekomendasi teknis-profesional kepada Direktur terkait penerbitan atau pencabutan Surat Penugasan Klinis (SPK).
2. Fungsi komite tenaga kesehatan lain dalam kaitannya dengan pelayanan klinis rumah sakit
 - a. Menjamin tersedianya regulasi internal, panduan operasional, dan kepatuhan terhadap Standar Prosedur Operasional (SPO) teknis di seluruh unit penunjang dan terapi.
 - b. Menjaga kualitas asuhan penunjang melalui perumusan indikator kinerja dan pelaksanaan audit klinis berkala (seperti waktu tunggu resep racikan, angka sirkulasi rekam medis, kejadian drop foot/cedera sekunder pada tindakan Fisioterapi, dll).
 - c. Mengintegrasikan proses perbaikan mutu profesi staf dengan Sasaran Keselamatan Pasien (SKP 1 tentang identifikasi pasien, SKP 2 tentang komunikasi efektif nilai kritis, dan SKP 6 tentang pengurangan risiko pasien jatuh pada area rehabilitasi/terapi fisik).
 - d. Mengusulkan solusi konkret berupa *Corrective Action Plan* (CAP) kepada pihak manajemen atas temuan kendala praktik asuhan.
3. Fungsi komite tenaga kesehatan lain dalam kaitan dengan anggota komite/staf fungsional
 - a. Menetapkan batas area praktik, kompetensi, dan rincian kewenangan fungsional staf penunjang berdasarkan keahlian riil.
 - b. Merumuskan buku saku panduan perilaku profesional staf KTKL.
 - c. Menyediakan instrumen penilaian kinerja klinis berkala melalui lembar Evaluasi Kinerja Profesional Berkelanjutan.
 - d. Memfasilitasi percepatan pemenuhan Satuan Kredit Profesi (SKP) digital staf melalui portal resmi Kementerian Kesehatan (SATUSEHAT SDM & Plataran Sehat).

BAB II

STANDAR KETENAGAAN

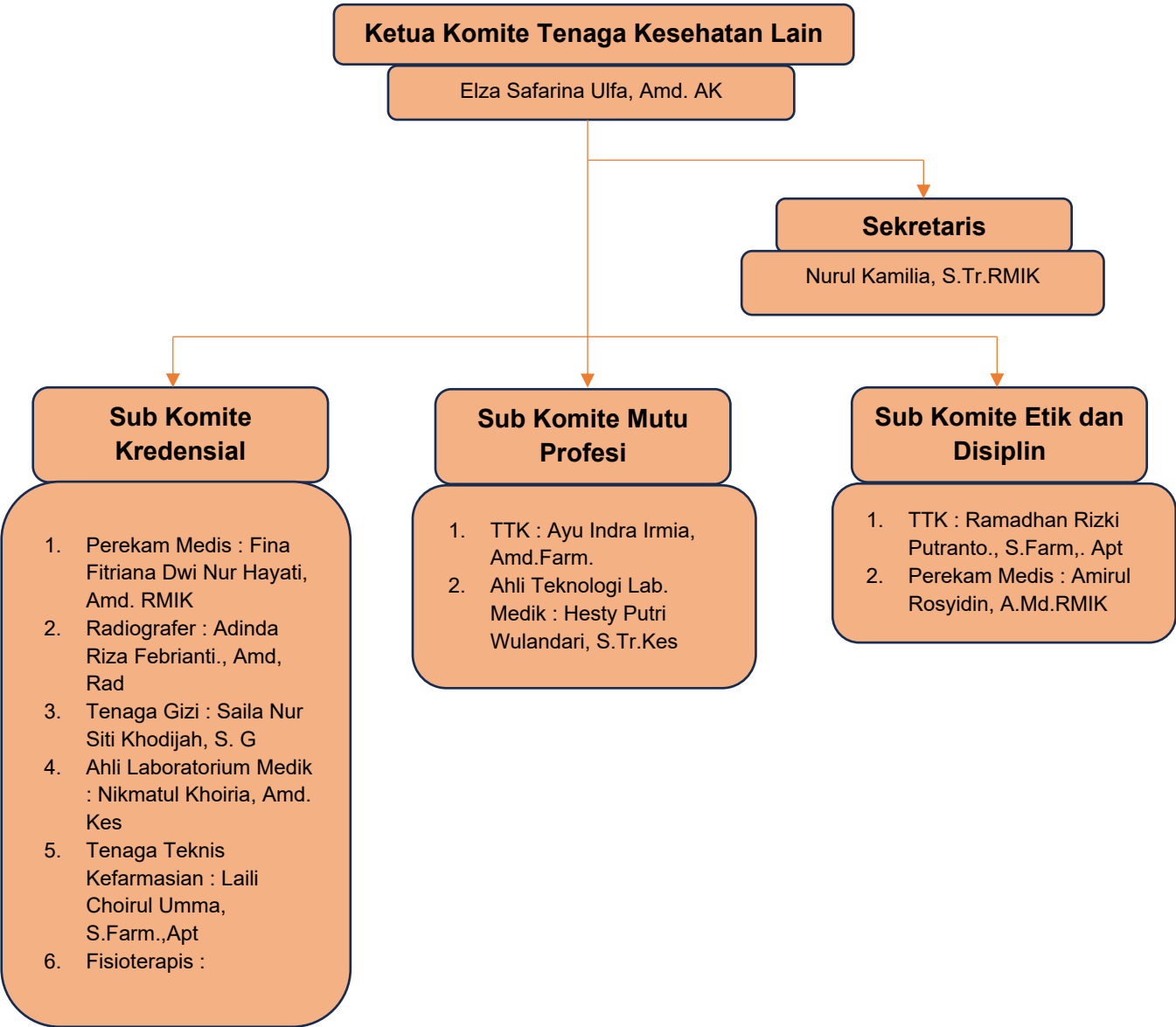
2.1 Kualifikasi Sumber Daya Manusia

1. Komite Tenaga Kesehatan Lain terdiri dari personel yang mempunyai komitmen, energi, waktu yang cukup, pengalaman kerja, serta latar belakang pendidikan di bidang rumpun profesi Tenaga Kesehatan Lain yang terkait.
2. Anggota Komite merupakan perwakilan resmi dari setiap bidang keahlian pelayanan penunjang medis dan terapi fisik di rumah sakit.
3. Jumlah anggota dipastikan mencukupi untuk menyelesaikan seluruh tugas dan program kerja komite.

2.2 Distribusi Ketenagaan

1. Ketua Komite
 - a. Ketua Komite Tenaga Kesehatan Lain memiliki latar belakang pendidikan minimal Diploma Tiga (D3) pada salah satu rumpun profesi Tenaga Kesehatan Lain yang bernaung di bawah komite.
 - b. Ketua Komite Tenaga Kesehatan Lain ditetapkan oleh Direktur Rumah Sakit dengan memperhatikan masukan dari seluruh tenaga kesehatan penunjang yang bekerja aktif di rumah sakit.
 - c. Masa jabatan Ketua Komite adalah selama 2 (dua) tahun.
 - d. Sekretaris Komite
2. Sekretaris Komite
 - a. Sekretaris Komite Tenaga Kesehatan Lain memiliki latar belakang pendidikan minimal Diploma Tiga (D3), Diploma Empat (D4), atau Sarjana (S1) pada salah satu rumpun profesi Tenaga Kesehatan Lain yang aktif di rumah sakit.
 - b. Sekretaris Komite Tenaga Kesehatan Lain ditetapkan oleh Direktur Rumah Sakit berdasarkan rekomendasi resmi dari Ketua Komite Tenaga Kesehatan Lain.
 - c. Masa jabatan Sekretaris Komite adalah selama 2 (dua) tahun.
3. Sub Komite Tenaga Kesehatan Lain
 - a. Pengurus Subkomite memiliki latar belakang pendidikan minimal Diploma Tiga (D3), Diploma Empat (D4), atau Sarjana (S1) dari rumpun profesi Ahli Teknologi Laboratorium Medis, Apoteker/Tenaga Teknis Kefarmasian, Radiografer, Tenaga Gizi, Perekam Medis, atau Fisioterapis.
 - b. Subkomite terdiri dari Ketua Subkomite dan Anggota Subkomite.
 - c. Ketua Subkomite ditetapkan oleh Direktur Rumah Sakit berdasarkan rekomendasi tertulis dari Ketua Komite Tenaga Kesehatan Lain.
 - d. Masa jabatan Ketua dan Anggota Subkomite adalah selama 2 (dua) tahun.
 - e. Untuk menyelesaikan tugas-tugas khusus, subkomite dapat membentuk tim kerja atau kelompok kerja sesuai dengan kebutuhan atau permasalahan klinis yang teridentifikasi saat itu.

2.3 Struktur Organisasi Komite Tenaga Kesehatan Lain



Bagan 2.1.1 Struktur Organisasi Komite Tenaga Kesehatan Lain

2.4 Uraian Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang

2.4.1 Ketua Komite Tenaga Kesehatan Lain

a. Uraian Tugas

a. Tugas Umum

1. Merencanakan program dan anggaran komite tenaga kesehatan lain, pembinaan, penilaian, pengembangan baik tata laksana kerja tugas-tugas dan karyawan, peningkatan kinerja dan mutu pelayanan tenaga kesehatan lain.
2. Menetapkan pembagian tugas, batas-batas tugas, tanggung jawab, kewenangan hubungan kerja yang jelas bagi karyawan sesuai dengan bidang pekerjaan masing-masing.
3. Memberi pengarahan dan koordinasi terhadap pelaksanaan tugas pelayanan guna tercapai tujuan pelayanan secara efektif dan efisien dalam suasana kerja yang kondusif.
4. Melakukan pengawasan/pengontrolan mencakup tugas: meneliti, menganalisis pekerjaan yang sudah dan

sedang dilaksanakan, menilai hasil pekerjaan dan mengoreksi, merevisi pekerjaan guna tercapai tujuan akhir pelayanan (kepuasan pelanggan) sesuai rencana yang telah ditetapkan.

5. Melakukan koordinasi dengan unit atau penanggung jawab program lain dan manajemen

b. Tugas Khusus

1. Merencanakan atau melaksanakan pelatihan dalam lingkup tenaga kesehatan lain dan kebidanan.
2. Menyusun daftar rincian kewenangan klinis dan logbook
3. Melakukan verifikasi persyaratan kredensial
 - Ijazah
 - Surat tanda registrasi [STR]
 - Sertifikat kompetensi
 - Logbook yang berisi uraian capaian kinerja
 - Surat pernyataan telah menyelesaikan program orientasi rumah sakit atau orientasi di unit tertentu bagi tenaga kesehatan lain baru
 - Surat hasil pemeriksaan kesehatan sesuai ketentuan.
4. Merekomendasikan kewenangan klinis tenaga kesehatan lain ;
5. Merekomendasikan pemulihan kewenangan klinis ;
6. Melakukan kredensial ulang secara berkala sesuai waktu yang ditetapkan ;
7. Melaporkan seluruh proses kredensial kepada ketua komite tenaga kesehatan lain untuk diteruskan kepada kepala /direktur Rumah Sakit.

b. Tanggung Jawab

1. Menetapkan rencana kerja komite tenaga kesehatan lain sesuai tujuan atau target pelayanan yang ingin dicapai Rumah Sakit.
2. Menetapkan pembagian pekerjaan, batasan tugas, tanggung jawab serta wewenang dan hubungan kerja yang jelas
3. Mensupervisi dan mengkoordinasi bagian-bagian pelayanan.
4. Melakukan pengawasan dan pengontrolan bidang pelayanan tenaga kesehatan lain.

c. Wewenang

1. Pengkoordinasian dan pengawasan kegiatan
2. Penyusunan rencana kerja tahunan Merekomendasikan kebutuhan pengembangan profesionalisme berkelanjutan berdasarkan asesmen kompetensi.
3. Pengarahan dan pengaturan tugas
4. Memimpin rapat

2.4.2 Sekretaris Komite Tenaga Kesehatan Lain

a. Uraian Tugas

1. Mencatat, menyimpan & melaporkan setiap kegiatan komite tenaga kesehatan lain
2. Mengelola kantor komite Tenaga Kesehatan Lain.

b. Tanggung Jawab

1. Menetapkan rencana kerja komite tenaga kesehatan lain sesuai tujuan dan target pelayanan yang ingin dicapai rumah sakit
2. Menetapkan pembagian pekerjaan, Batasan tugas, tanggung jawab serta wewenang dan hubungan kerja yang jelas Lain.

c. Wewenang

1. Pelaporan
2. Pengarahan kegiatan

2.4.3 Sub Komite Kredensial

- a. Uraian Tugas
 1. Melakukan kredensial
 2. Mengatur wewenang profesi
 3. Menyusun program orientasi Sakit.
- b. Tanggung Jawab
 1. Menetapkan rencana kerja komite tenaga kesehatan lain sesuai tujuan dan target pelayanan yang ingin dicapai rumah sakit
 2. Menetapkan pembagian pekerjaan, batasan tugas, tanggung jawab serta wewenang dan hubungan kerja yang jelas.
- c. Wewenang
 1. Pelaporan
 2. Pengarahan

2.4.4 Sub Komite Mutu Profesi

- a. Uraian Tugas
 1. Membuat rencana kerja atau program kerja sub komite mutu
 2. Melakukan audit tenaga kesehatan lain
 3. Mengembangkan diklat
 4. Melakukan monitoring dan evaluasi program kebutuhan
- b. Tanggung Jawab
 1. Menetapkan rencana kerja komite Tenaga Kesehatan Lain sesuai tujuan dan target pelayanan yang ingin dicapai rumah sakit.
 2. Menetapkan pembagian pekerjaan, batasan tugas, tanggung jawab serta wewenang dan hubungan kerja yang jelas.
- c. Wewenang
 1. Memberikan Pelaporan
 2. Pengarahan

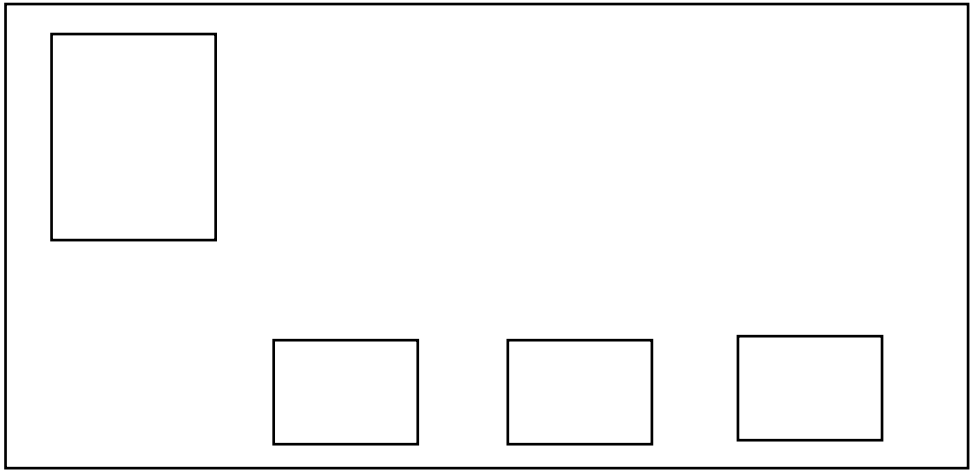
2.4.5 Sub Komite Etik dan Disiplin

- a. Uraian Tugas
 1. Pedoman etik & sosialisasi
 2. Mengelola mekanisme masalah etik
 3. Pemulihan nama baik
 4. Mekanisme ijin penelitian
 5. Mekanisme perlindungan hukum.
- b. Tanggung Jawab
 1. Menetapkan rencana kerja komite Tenaga Kesehatan Lain sesuai tujuan dan target pelayanan yang ingin dicapai rumah sakit
 2. Menetapkan pembagian pekerjaan, batasan tugas, tanggung jawab serta wewenang dan hubungan kerja yang jelas
- c. Wewenang
 1. Pelaporan
 2. Pengarahan.

BAB III

STANDAR FASILITAS

3.1 Denah Ruangan



3.2 Standar Fasilitas

d. Tabel 3.2.1 Standar Fasilitas Ruang Komite Tenaga Kesehatan Lain

No	Fasilitas	Standar
1	Meja Kerja	1
2	Kursi kerja	1
3	Komputer	1
4	Printer	1

BAB IV

TATALAKSANA PELAYANAN

4.1 Proses Kredensial

1. Tujuan Kredensial

- Menjamin bahwa Tenaga Kesehatan Lain yang memberikan pelayanan di RS Prima Husada Sukorejo telah memenuhi standar kompetensi profesi dan memiliki kewenangan klinis sah.
- Menjaga mutu pelayanan penunjang medis dan keselamatan pasien.
- Menjadi dasar dan acuan bagi Direktur Rumah Sakit dalam menetapkan serta menerbitkan Surat Penugasan Klinis bagi staf Tenaga Kesehatan Lain.

2. Ruang Lingkup

Proses kredensial dan rekredensial ini berlaku wajib untuk :

- Staf Baru: Tenaga Kesehatan Lain yang baru diterima bekerja dan akan mulai memberikan pelayanan di rumah sakit.
- Staf Lama (Rutin): Tenaga Kesehatan Lain yang melakukan perpanjangan kewenangan klinis secara berkala (setiap 3 tahun sekali).
- Kondisi Khusus (Insidental): Tenaga Kesehatan Lain yang mengalami perubahan kewenangan klinis, baik berupa penambahan kompetensi baru, pembatasan wewenang, mutasi ke unit pelayanan khusus/intensif, maupun pencabutan kewenangan klinis akibat faktor tertentu.

3. Pihak yang Terlibat

- Staf Tenaga Kesehatan Lain yang mengajukan permohonan kredensial/rekredensial.
- Atasan langsung / Kepala Unit Kerja terkait (untuk memberikan penilaian kinerja klinis harian, verifikasi buku *logbook*, serta memberikan rekomendasi).
- Subkomite Kredensial Komite Tenaga Kesehatan Lain (KTKL) beserta Mitra Bestari profesi terkait.
- Ketua Komite Tenaga Kesehatan Lain (KTKL).
- Direktur Rumah Sakit (sebagai pejabat berwenang yang menerbitkan keputusan legalitas kewenangan klinis staf).

4. Prosedur Kredensial Staf Tenaga Kesehatan Lain

Tabel 4.1.1 Prosedur Kredensial Staf Tenaga Kesehatan Lain

No	Tahapan	Uraian Kegiatan	Penanggung Jawab	Dokumen
1	Pengajuan	Staf mengajukan permohonan kredensial/perpanjangan kewenangan dengan mengisi formulir dan melampirkan berkas persyaratan	Staf Farmasi, Fisioterapis, Radiografer, ATLM, Tenaga Gizi, dan Perekam Medis	Formulir permohonan, ijazah, STR, SIP, sertifikasi kompetensi/ pelatihan, logbook
2	Verifikasi Administrasi	Pemeriksaan kelengkapan dokumen dan legalitas berkas	Sekretaris Komite Tenaga Kesehatan Lain	Daftar cek verifikasi
3	Penilaian Kredensial	Sub Komite Kredensial melakukan penilaian terhadap: Kualifikasi pendidikan	Subkomite Kredensial	Form penilaian kredensial

		• STR dan SIP • Kompetensi & pengalaman kerja • Rekam jejak etik dan disiplin • Evaluasi kinerja sebelumnya (jika perpanjangan)		
4	Wawancara dan Uji Kompetensi	Melakukan kompetensi, klarifikasi atau uji keterampilan untuk memastikan kompetensi klinis	Subkomite Kredensial	Berita acara
5	Rapat Kredensial	Hasil penilaian dibahas dalam rapat subkomite kredensial dan komite Tenaga Kesehatan Lain untuk menetapkan rekomendasi	Komite Tenaga Kesehatan Lain	Notulen dan berita acara rapat
6	Pemberian Rekomendasi	Komite Tenaga Kesehatan Lain memberikan rekomendasi tertulis kepada Direktur tentang jenis kewenangan klinis yang layak diberikan	Ketua Komite Tenaga Kesehatan Lain	Surat Rekomendasi
7	Penetapan Kewenangan Klinis	Direktur rumah sakit menerbitkan Surat Penetapan Kewenangan Klinis berdasarkan rekomendasi Komite Tenaga Kesehatan Lain	Direktur RS	SK Kewenangan Klinis
8	Distribusi dan Sosialisasi	SK kewenangan klinis disampaikan ke unit kerja, bidang Tenaga Kesehatan Lain, dan staf yang bersangkutan	Bidang Tenaga Kesehatan Lain	Daftar distribusi
9	Penyimpanan Dokumen	Seluruh dokumen kredensial disimpan rapi dalam arsip Komite Tenaga Kesehatan Lain dan rekam kepegawaian	Sekretaris Komite	Arsip fisik dan elektronik

5. Persyaratan Dokumen Kredensial

Perawat wajib melampirkan:

- Fotocopy Ijazah terakhir
- STR (Surat Tanda Registrasi) aktif
- SIP (Surat Izin Praktik) aktif
- Sertifikat pelatihan kompetensi sesuai bidang
- Daftar riwayat pekerjaan dan pengalaman kerja
- Logbook kegiatan klinis
- Penilaian kinerja terakhir (untuk perpanjangan)

6. Perpanjangan, perubahan dan pencabutan kewenangan klinis

- Perpanjangan dilakukan setiap 3 tahun dengan proses kredensial ulang
- Perubahan kewenangan dapat dilakukan bila perawat telah mengikuti pelatihan atau pindah bidang praktik
- Pencabutan/ pembatasan dilakukan bila :
 - 1) STR/SIP tidak berlaku

- 2) Staf melakukan pelanggaran etik/ disiplin berat
 - 3) Staf tidak memenuhi kompetensi atau kinerja tidak sesuai standar.
7. Monitoring dan evaluasi
- a. Komite Tenaga Kesehatan Lain melakukan evaluasi kewenangan klinis secara berkala
 - b. Bidang Tenaga Kesehatan Lain dan unit kerja melaporkan setiap kejadian ketidaksesuaian praktik Tenaga Kesehatan Lain kepada Komite
 - c. Evaluasi kredensial menjadi bagian dari indikator mutu Tenaga Kesehatan Lain dan audit internal rumah sakit.

4.2 Rekredensial Berkala dan Insidental

1. Rekredensial Rutin
Staf wajib mengajukan permohonan rekredensial tertulis 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Surat Penugasan Klinis lamanya berakhir. Alur administrasi mengikuti tata cara kredensial awal dengan fokus utama mengevaluasi buku catatan kinerja klinis (*logbook*) dan capaian mutu profesi staf selama 3 tahun terakhir.
2. Rekredensial Sewaktu-Waktu (Insidental)
Pelaksanaan rekredensial dapat dipercepat atau dilakukan sewaktu-waktu apabila staf memperoleh kompetensi baru (menyelesaikan jenjang pendidikan/pelatihan keahlian klinis khusus) atau jika staf mengalami perubahan kondisi kesehatan jasmani dan mental yang berpotensi memengaruhi mutu serta keamanan keselamatan pasien.
3. Hasil Keputusan Rekredensial
Rekomendasi yang dirumuskan oleh Subkomite Kredensial dan Ketua KTKL kepada Direktur dapat berupa: Dilanjutkan, Ditambah, Dikurangi/Dibatasi, atau Dibekukan/Diakhiri apabila ditemukan pelanggaran disiplin mutu atau etik berat.

2.5 Sub Komite Mutu Profesi

1. Tujuan Penjagaan Mutu Profesi
 - a. Memastikan pelayanan yang diberikan oleh Tenaga Kesehatan Lain (Tenaga Teknis Kefarmasian/Apoteker, Radiografer, Ahli Teknologi Laboratorium Medik, Tenaga Gizi, Perekam Medis, dan Fisioterapis) senantiasa berjalan sesuai dengan standar profesi, standar prosedur operasional (SPO), dan berbasis pada bukti ilmiah terkini.
 - b. Mempertahankan dan meningkatkan kompetensi staf melalui pemantauan kinerja klinis secara mandiri dan terstruktur dalam program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB).
 - c. Meminimalkan risiko insiden klinis pada lini penunjang medis dan terapi fisik demi mendukung keselamatan pasien secara menyeluruh
2. Ruang Lingkup Mutu Profesi
Prosedur kerja Subkomite Mutu Profesi KTKL wajib mencakup:
 - a. Pelaksanaan audit klinis profesi berkala dan insidental pada unit kerja KTKL.
 - b. Pengelolaan dan pemantauan pengisian buku catatan kinerja klinis (*logbook*) seluruh staf.
 - c. Pelaksanaan pendampingan klinis bagi staf baru atau pasca-mutasi ruang intensif.
 - d. Penyelenggaraan program pengembangan profesi berkelanjutan (CPD) berkoordinasi dengan Unit Diklat.

- e. Fasilitasi forum pembelajaran klinis melalui Diskusi Refleksi Kasus (DRK).
3. Prosedur Audit Mutu Profesi

Pelaksanaan audit mutu profesi dirancang untuk mengevaluasi kesesuaian antara praktik di lapangan dengan standar profesi penunjang medik:

 - a. Perencanaan Audit: Subkomite Mutu Profesi menetapkan topik atau indikator area audit prioritas setiap semester. Contoh indikator penunjang dan terapi: ketepatan waktu penyerahan obat (Farmasi), tingkat penolakan film foto rontgen (Radiologi), waktu tunggu hasil laboratorium nilai kritis (ATLM), ketepatan diet pasien (Gizi), angka ketidaklengkapan pengisian rekam medis (Perekam Medis), atau kejadian cedera otot/sendi penyerta saat mobilisasi pasien (Fisioterapi).
 - b. Pengumpulan dan Analisis Data: Pengumpulan sampel data atau observasi langsung dilakukan di lapangan bersama Kepala Instalasi unit terkait. Hasil data dikompilasi untuk dianalisis kesenjangannya.
 - c. Penyusunan Rencana Tindak Lanjut: Jika ditemukan penyimpangan atau kendala dari standar, Subkomite merumuskan rekomendasi perbaikan berupa penyegaran prosedur (SPO), perbaikan alur pelayanan, atau usulan perbaikan sarana penunjang.
 - d. Pelaporan: Laporan hasil audit mutu disampaikan kepada Ketua KTKL untuk diteruskan kepada Direktur Rumah Sakit dan Kepala Bidang Pelayanan sebagai dasar evaluasi manajerial.
4. Diskusi Refleksi Kasus (DRK) diselenggarakan sebagai wadah pembelajaran ilmiah non-blaming (tidak menyalahkan) apabila terjadi kasus signifikan atau insiden keselamatan pasien:
 - a. Identifikasi Kasus: Kepala Instalasi atau Mutu Unit melaporkan adanya kasus/insiden klinis penunjang bernilai pembelajaran (misal: kejadian nyaris cedera/KNC terkait salah penulisan label sampel laboratorium, insiden salah pemberian diet pasien, atau kendala pelepasan informasi medis pada rekam medis).
 - b. Persiapan Forum: Subkomite Mutu Profesi menjadwalkan pertemuan DRK dan menunjuk satu orang staf penunjang terkait untuk memaparkan kronologi kasus secara objektif berdasarkan data rekam medis.
 - c. Sesi Refleksi dan Diskusi: Anggota forum lintas profesi KTKL membedah kasus bersama-sama untuk mengidentifikasi akar masalah klinis, aspek kognitif, maupun hambatan sistemik pelayanan.
 - d. Formulasi Solusi: Forum menghasilkan simpulan komitmen perbaikan mutu, revisi SPO yang kurang adaptif, atau rekomendasi pelatihan spesifik yang diajukan ke jajaran manajemen demi mencegah berulangnya kasus serupa.
 - a. Pemeliharaan Kompetensi Berkelanjutan (Continuous Professional Development / CPD)
5. Subkomite Mutu Profesi wajib memelihara tingkat kognitif dan psikomotorik staf melalui mekanisme:
 - a. Validasi Buku Catatan Kinerja Klinis (*Logbook*) Tahunan: Melakukan verifikasi capaian tindakan klinis di dalam buku catatan harian staf yang telah ditandatangani Kepala Ruangan untuk memastikan tenaga kesehatan tetap rutin melakukan tindakan sesuai kewenangan klinisnya.
 - b. Rekomendasi Pendidikan dan Pelatihan: Mendata kebutuhan diklat profesi (seperti pelatihan pencampuran obat steril, proteksi radiasi terbaru, kalibrasi alat laboratorium mutakhir, asuhan gizi kritis ICU, implementasi rekam medis elektronik, maupun teknik rehabilitasi neuromuskular/kardiorespirasi mutakhir pada Fisioterapi), serta

memberikan rekomendasi tertulis kepada Bagian SDM/Diklat untuk memprioritaskan keikutsertaan staf.

6. Prosedur Pendampingan Klinis

- a. Pendampingan klinis wajib diberikan kepada staf baru selama masa orientasi khusus 3 (tiga) bulan pertama atau staf lama yang baru saja mendapatkan perluasan kewenangan klinis tingkat lanjut.
- b. Subkomite Mutu Profesi menunjuk staf senior di unit kerja terkait bertindak sebagai pendamping/pengawas.
- c. Selama proses pendampingan, staf dilarang melakukan tindakan berisiko tinggi secara mandiri penuh sebelum ditinjau, dinilai, dan dinyatakan kompeten aman secara tertulis oleh staf pendamping seniornya. Hasil penilaian ini menjadi modalitas utama yang diserahkan ke Subkomite Kredensial untuk penerbitan izin praktik mandiri.

2.6 Sub Komite Etik dan Disiplin Profesi

1. Tujuan Penegakan Etik dan Disiplin Profesi

- a. Melindungi pasien, masyarakat, dan citra RS Prima Husada Sukorejo dari tindakan pelayanan yang tidak etis atau tidak profesional oleh staf Tenaga Kesehatan Lain.
- b. Mengakkan kepatuhan staf (Tenaga Teknis Kefarmasian/Apoteker, Radiografer, Ahli Teknologi Laboratorium Medik, Tenaga Gizi, Perekam Medis, **dan Fisioterapis**) terhadap kode etik profesinya masing-masing serta peraturan internal rumah sakit (*Hospital Bylaws* dan *Staff Bylaws*).
- c. Membina kepribadian dan perilaku kerja staf agar selalu menunjukkan integritas, tanggung jawab, empati, dan profesionalisme tinggi dalam memberikan pelayanan.

2. Ruang Lingkup Etik dan Disiplin Profesi

Prosedur kerja Subkomite Etik dan Disiplin Profesi KTKL meliputi:

- a. Sosialisasi berkala mengenai kode etik profesi rumpun tenaga kesehatan penunjang medik dan terapi.
- b. Pengawasan terhadap perilaku profesional sehari-hari staf di unit kerja masing-masing.
- c. Investigasi, pemeriksaan, dan penanganan terhadap laporan atau pengaduan dugaan pelanggaran etik dan disiplin profesi.
- d. Pemberian rekomendasi sanksi profesi atau pemulihan hak (rehabilitasi) kepada Direktur Rumah Sakit.

3. Prosedur Pembinaan dan Pengawasan Perilaku Etis

- a. Pembekalan Etik: Subkomite Etik dan Disiplin Profesi secara rutin menyelenggarakan penyegaran terkait pemahaman regulasi profesi, hak dan kewajiban pasien, serta batas-batas perilaku profesional yang diperbolehkan di rumah sakit.
- b. Pengawasan Melekat: Subkomite bekerja sama dengan Kepala Ruangan atau Kepala Instalasi unit terkait untuk melakukan pemantauan harian terhadap kedisiplinan kerja, etika berkomunikasi kepada pasien/sejawat, serta komitmen menjaga kerahasiaan data medis pasien (terutama pada lini Rekam Medis, Laboratorium, dan area privasi tindakan Fisioterapi).

4. Prosedur Penanganan Pelanggaran Etik dan Disiplin Profesi

Apabila terdapat laporan tertulis atau pengaduan (baik dari pasien, rekan kerja, dokter, maupun manajemen) mengenai dugaan pelanggaran oleh staf KTKL, alur penanganannya adalah sebagai berikut:

- a. Penerimaan Laporan: Laporan atau pengaduan tertulis diterima oleh Ketua KTKL dan diteruskan kepada Subkomite Etik dan Disiplin Profesi untuk ditelaah kelayakannya maksimal 3 (tiga) hari kerja.
 - b. Tahap Klarifikasi (Pemeriksaan Awal): Subkomite melakukan pengumpulan bukti fisik/dokumen pendukung dan memanggil pihak pelapor, saksi-saksi, serta staf terlapor secara terpisah untuk dimintai keterangan tertulis di bawah Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
 - c. Pembentukan Panitia Ad-Hoc (Jika Diperlukan): Apabila kasus bersifat kompleks atau berskala berat, Ketua KTKL dapat membentuk Panitia Ad-Hoc yang melibatkan pengurus KTKL, unsur manajemen SDM, serta perwakilan Mitra Bestari (*Peer Group*) dari organisasi profesi yang bersangkutan untuk menjaga objektivitas penilaian.
5. Sesi Sidang Panel Etik dan Pengambilan Keputusan
- a. Subkomite menggelar sidang panel tertutup untuk mengkaji seluruh hasil pemeriksaan dan menentukan apakah staf terbukti melakukan pelanggaran.
 - b. Kategorisasi Pelanggaran: Keputusan pelanggaran diklasifikasikan ke dalam tiga tingkatan:
 - o Pelanggaran Ringan: Perilaku yang tidak berdampak langsung pada keselamatan pasien (misal: ketidakpatuhan atribut seragam, tidak ramah, atau pelanggaran disiplin jam kerja minor).
 - o Pelanggaran Sedang: Kelalaian prosedur administratif/pelayanan yang berpotensi membahayakan pasien atau merugikan operasional RS (misal: ketidaklengkapan pengarsipan data penting, atau pengabaian SPO komunikasi serah terima obat/sampel).
 - o Pelanggaran Berat: Tindakan yang sengaja melanggar hukum, membahayakan nyawa pasien, atau merusak nama baik RS (misal: membocorkan rahasia rekam medis pasien ke pihak luar secara ilegal, pemalsuan hasil laboratorium, bekerja di bawah pengaruh alkohol/narkoba, atau melakukan tindakan asusila).
6. Formulasi Rekomendasi Sanksi Profesi
- Hasil keputusan sidang dirumuskan dalam bentuk surat rekomendasi resmi dari Ketua KTKL yang diajukan kepada Direktur Rumah Sakit. Jenis sanksi profesi yang dapat direkomendasikan meliputi:
- a. Sanksi Pembinaan (Pelanggaran Ringan): Berupa teguran lisan, teguran tertulis, atau kewajiban mengikuti konseling pembinaan perilaku.
 - b. Sanksi Pembatasan (Pelanggaran Sedang): Berupa pengurangan atau pembatasan sebagian kewenangan klinis staf untuk jangka waktu tertentu, serta kewajiban bekerja di bawah supervisi ketat (*proctoring* ulang).
 - c. Sanksi Pencabutan (Pelanggaran Berat): Berupa rekomendasi pembekuan sementara atau pencabutan permanen terhadap Surat Penugasan Klinis, yang berimplikasi pada penyerahan keputusan ketenagakerjaan sepenuhnya kepada jajaran Direktur dan Bagian SDM (seperti pemutusan hubungan kerja).
7. Prosedur Pemulihan Kewenangan Klinis (Rehabilitasi)
- Bagi staf yang telah menjalani sanksi pembatasan atau pembekuan kewenangan klinis dan dinilai telah menunjukkan perbaikan perilaku serta kompetensi:
- a. Staf berhak mengajukan permohonan pemulihan hak klinis secara tertulis kepada Ketua KTKL setelah masa sanksinya berakhir.

- b. Subkomite Etik dan Disiplin bersama Subkomite Mutu Profesi melakukan evaluasi ulang terhadap catatan perilaku staf selama masa pembinaan.
- c. Jika dinyatakan telah pulih dan layak, KTKL akan mengirimkan surat rekomendasi pemulihan kepada Direktur Rumah Sakit agar Surat Penugasan Klinis staf dapat diaktifkan kembali.

BAB V

HUBUNGAN KERJA

5.1 Prinsip Umum

Hubungan kerja antara Komite Tenaga Kesehatan Lain (KTKL) dan Direktur Rumah Sakit bersifat koordinatif, fungsional, dan konsultatif, dengan tujuan mendukung peningkatan mutu pelayanan penunjang medis, menjaga profesionalisme staf Tenaga Kesehatan Lain, serta melindungi keselamatan pasien, tenaga kesehatan, dan rumah sakit.

Komite Tenaga Kesehatan Lain bersifat non-struktural dan tidak memiliki fungsi operasional pelayanan mandiri, namun bertanggung jawab memberikan pertimbangan profesional serta rekomendasi strategis kepada Direktur Rumah Sakit terkait praktik dan tata kelola klinis rumpun profesi Tenaga Teknis Kefarmasian/Apoteker, Fisioterapis, Radiografer, Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM), Tenaga Gizi, dan Perekam Medis.

5.2 Mekanisme Hubungan Kerja

a. Jalur Koordinasi

1. Komite Tenaga Kesehatan Lain melakukan koordinasi langsung dengan Direktur Rumah Sakit dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi seluruh kegiatan terkait kredensial, rekredensial, penjagaan mutu profesi, serta penegakan etik dan disiplin profesi.
2. Dalam pelaksanaan kegiatan operasionalnya, Komite Tenaga Kesehatan Lain berkoordinasi secara aktif dengan jajaran Kepala Instalasi/Unit Kerja terkait (Farmasi, Fisioterapis, Radiologi, Laboratorium, Gizi, Rekam Medis), Bidang Pelayanan, serta Bagian SDM rumah sakit sesuai dengan kebutuhan pemenuhan regulasi.
3. Setiap bentuk kegiatan, rekomendasi final, atau temuan evaluasi lapangan yang dihasilkan oleh Komite Tenaga Kesehatan Lain wajib dilaporkan secara resmi dan tertulis kepada Direktur Rumah Sakit.

b. Jalur Pelaporan

1. Laporan Komite Tenaga Kesehatan Lain berkewajiban menyampaikan laporan hasil evaluasi kinerja organisasi secara berkala (triwulan dan tahunan) kepada Direktur Rumah Sakit, yang meliputi:
 - a) Rekapitulasi pencapaian kegiatan kredensial, rekredensial, dan status masa berlaku STR/SIP staf.
 - b) Pelaksanaan program pembinaan mutu, uji kompetensi, dan evaluasi kepatuhan nakes.
 - c) Hasil pelaksanaan audit mutu profesi penunjang medik dan Diskusi Refleksi Kasus (DRK).
 - d) Rekam jejak penanganan kasus etik dan disiplin profesi serta status rekomendasi penyelesaiannya.
2. Laporan Insidental: Jika dalam proses pengawasan ditemukan indikasi pelanggaran serius, penurunan kondisi kesehatan nakes yang drastis, atau kondisi operasional di unit penunjang yang dapat membahayakan keselamatan pasien secara mendesak, Komite Tenaga Kesehatan Lain wajib menyusun dan mengirimkan laporan segera (insidental) pada hari yang sama kepada Direktur Rumah Sakit agar dapat langsung ditindaklanjuti secara manajerial.

c. Jalur Rekomendasi Profesional

1. Komite Tenaga Kesehatan Lain bertugas memberikan rekomendasi tertulis yang bersifat mengikat secara klinis kepada Direktur Rumah Sakit mengenai:

- a. Pemberian, perpanjangan, penambahan, pembatasan, pembekuan, atau pencabutan Surat Penugasan Klinis beserta daftar Rincian Kewenangan Klinis staf.
 - b. Rekomendasi program kedinasan berupa diklat spesifik, seminar, atau pendidikan berkelanjutan (CPD) bagi staf yang membutuhkan peningkatan kapasitas kognitif maupun psikomotor.
 - c. Pemberian sanksi profesi bagi staf yang terbukti melakukan pelanggaran etik/disiplin, atau pemberian surat pemulihan hak klinis bagi staf yang telah menyelesaikan masa pembinaan.
 - d. Usulan revisi Standar Prosedur Operasional (SPO) pelayanan penunjang atau pengadaan sarana-prasarana tertentu jika ditemukan celah sistem yang berisiko menimbulkan insiden klinis.
 2. Direktur Rumah Sakit menelaah dan menindaklanjuti rekomendasi dari KTKL tersebut ke dalam bentuk keputusan administratif dan operasional kedinasan, sesuai dengan batas wewenang manajerial tertinggi rumah sakit
- d. Rapat dan Konsultasi
1. Rapat koordinasi resmi antara Komite Tenaga Kesehatan Lain dan Direktur Rumah Sakit dilaksanakan secara berkala minimal 1 (satu) kali setiap 3 (tiga) bulan, atau dapat diselenggarakan sewaktu-waktu (insidental) bila terdapat pembahasan kasus yang bersifat mendesak.
 2. Agenda utama yang dilaksanakan di dalam rapat koordinasi berkala ini meliputi:
 - a. Penyampaian formal laporan kegiatan triwulan/tahunan KTKL.
 - b. Pembahasan bersama mengenai masalah strategis klinis terkait pelayanan kefarmasian, fisioterapi, radiologi, laboratorium, gizi, dan rekam medis.
 - c. Pemberian arahan, evaluasi, kebijakan makro, dan solusi pemecahan hambatan oleh Direktur Rumah Sakit.
 - d. Penetapan kesepakatan rencana tindak lanjut (RTL) beserta batas waktu penyelesaiannya

BAB VI

LOGISTIK

Penyediaan kebutuhan logistik Komite Tenaga Kesehatan Lain (KTKL) RS Prima Husada Sukorejo yang meliputi alat tulis kantor (ATK), alat cetak/ganda, toner printer, kertas, serta sarana penunjang kesekretariatan lainnya, termasuk ke dalam Rencana Anggaran Belanja (RAB) rumah sakit yang diajukan setiap tahunnya.

Pemeriksaan, pengawasan, dan pemenuhan kebutuhan logistik operasional KTKL dilakukan setiap hari oleh Sekretaris Komite . Jika terdapat kekurangan sarana, Sekretaris melakukan proses pemesanan atau pengorderan barang ke Bagian Gudang/Pengadaan Umum Rumah Sakit atas sepengetahuan dan persetujuan dari Ketua Komite Tenaga Kesehatan Lain.

Proses permintaan logistik tersebut wajib dilaksanakan secara tertib administratif melalui prosedur resmi berikut:

- a. Input Permintaan di SIMRS: Komite Tenaga Kesehatan Lain (KTKL) melalui Sekretaris Komite menginput data orderan barang yang dibutuhkan secara sistem digital pada modul Pengadaan Umum di Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS).
- b. Verifikasi oleh Petugas Gudang: Petugas Gudang Umum rumah sakit menerima notifikasi sistem, lalu melakukan proses verifikasi, pengecekan ketersediaan stok fisik barang, serta melakukan persetujuan sebelum menyiapkan barang-barang yang diminta oleh komite.
- c. Pemeriksaan Fisik dan Serah Terima: Pada saat pengambilan barang di area gudang penyerahan, petugas Gudang Umum dan Sekretaris KTKL melakukan pemeriksaan bersama terkait kesesuaian jenis, jumlah, dan kondisi fisik barang. Setelah dipastikan sesuai dan dalam kondisi baik, dilakukan proses serah terima dan pemutakhiran status order pada SIMRS.

BAB VII

KESELAMATAN PASIEN

Keselamatan pasien merupakan salah satu indikator keberhasilan mutu pelayanan Tenaga Kesehatan Lain yang dipantau oleh Komite Tenaga Kesehatan Lain bekerja sama dengan Tim Keselamatan Pasien Rumah Sakit.

Solusi atau program termasuk Standar Prosedur Operasional (SPO) yang terkait dengan keselamatan pasien, yang diterapkan bersama Komite Keselamatan Pasien Rumah Sakit agar tercapai keselamatan pasien pada setiap asuhan dan pelayanan yang diberikan oleh Tenaga Kesehatan Lain adalah:

1. Perhatikan nama obat, rupa, ucapan mirip (*look alike, sound alike medication names*).
 - a. Nama obat rupa dan ucapan mirip (NORUM) yang membingungkan staf pelaksana adalah salah satu penyebab yang sering dalam kesalahan obat (*medication error*).
 - b. Solusi NORUM yang ditekankan oleh Komite Tenaga Kesehatan Lain adalah penekanan pada penggunaan protokol untuk pengurangan risiko dan memastikan terbacanya resep, label, sehingga obat – obat yang perlu diwaspadai mendapat pengelolaan baik.
2. Pastikan identifikasi pasien
 - a. Kegagalan yang meluas dan terus menerus untuk mengidentifikasi pasien secara benar sering mengarah kepada kesalahan pengobatan, tranfusi, maupun pemeriksaan.
 - b. Rekomendasi yang ditekankan pada metoda untuk verifikasi terhadap identitas pasien, termasuk keterlibatan pasien dan keluarganya adalah penggunaan gelang pasien.
3. Komunikasi secara benar saat serah terima / pengoperan pasien
 - a. Kesenjangan dalam komunikasi saat serah terima/ pengoperan pasien antar unit pelayanan, dan antar tim pelayanan bisa mengakibatkan terputusnya kesinambungan layanan, pengobatan yang tidak tepat, dan potensial dapat mengakibatkan cedera pada pasien.
 - b. Rekomendasi ditujukan untuk memperbaiki pola serah terima pasien termasuk penggunaan protokol untuk mengkomunikasikan informasi yang bersifat kritis.
4. Identifikasi pasien jatuh

Adalah tata cara penilaian dan identifikasi terhadap pasien dengan risiko jatuh (terutama pada area latihan rehabilitasi fisik/fisioterapi dan ruang tunggu pelayanan), kemudian mengambil langkah-langkah proteksi aktif untuk mengurangi risiko pasien terjatuh.
5. Tingkatkan kebersihan tangan (*hand hygiene*)
 - a. Kebersihan tangan yang efektif adalah ukuran preventif yang primer untuk menghindarkan masalah penyebaran infeksi.
 - b. Rekomendasinya adalah mendorong implementasi penggunaan handrub atau handwash tersedia pada titik – titik pelayanan.
 - c. Pendidikan staf mengenai teknik kebersihan tangan yang benar, mengingatkan penggunaan tangan tangan bersih ditempat kerja merupakan pencegahan penyebaran infeksi.
6. Pelaporan insiden keselamatan pasien

Pelaporan dilakukan secara berkala dan berjenjang sebagai awal dari proses pembelajaran bersama untuk mencegah kejadian atau kekeliruan yang sama terulang kembali di masa depan.

7. Pembinaan dan pengawasan

Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program – program keselamatan pasien melalui diskusi refleksi kasus dan melakukan evaluasi audit indikator mutu klinik Tenaga Kesehatan Lain yang dilakukan setiap harinya melalui supervisi Tenaga Kesehatan Lain dan dibuat laporan tiap bulannya.

BAB VIII

KESELAMATAN KERJA

Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan salah satu indikator keberhasilan mutu kinerja Tenaga Kesehatan Lain yang dipantau oleh Komite Tenaga Kesehatan Lain bekerja sama dengan Tim Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit (K3RS), yang dilakukan melalui langkah-langkah berikut:

1. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kelengkapan keselamatan kerja serta pengendalian terhadap Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di lingkungan laboratorium, farmasi, maupun radiologi. Hal ini diperkuat dengan penyusunan SPO tentang penyediaan dan pemakaian Alat Pelindung Diri (APD) yang sesuai standar paparan risiko masing-masing unit kerja.
2. Turut aktif membantu mengidentifikasi, mencatat, dan menentukan kasus-kasus kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja di lini penunjang medis dan terapi fisik, serta berusaha melakukan tindak lanjut penanganan sesuai dengan batas wewenang profesi.
3. Memberikan rekomendasi atau masukan mengenai perencanaan, pembuatan tempat kerja, serta pemilihan dan pengadaan alat kesehatan terkait dengan keselamatan dan kesehatan pekerja. Hal ini bertujuan agar Tenaga Kesehatan Lain sebagai pengguna (*user*) dapat bekerja dengan aman, serta meminimalkan risiko kerja (seperti paparan radiasi, risiko ergonomi cedera punggung pada fisioterapis saat memindahkan pasien, atau paparan uap zat kimia).
4. Turut membantu dalam mengajukan usulan pemeriksaan kesehatan berkala bagi tenaga kerja fungsional, serta memelihara hubungan yang harmonis dengan jajaran manajemen rumah sakit demi terwujudnya lingkungan kerja yang sehat dan kondusif.

BAB IX

PENGENDALIAN MUTU

Pengendalian mutu Komite Tenaga Kesehatan Lain (KTKL) Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo dan indikator mutu pelayanan penunjang medik serta terapi fisik telah terintegrasi untuk mengukur kinerja klinis staf pada masing-masing rumpun profesi. Guna mewujudkan komitmen pelayanan yang aman, KTKL menggunakan indikator kinerja klinis spesifik sebagai instrumen untuk menilai tingkat kemampuan dan akurasi individu dalam tim kerja pelayanan kesehatan.

Beberapa indikator mutu klinis yang dipantau oleh Komite Tenaga Kesehatan Lain untuk pengendalian mutunya meliputi:

1. Keselamatan Pasien (*Patient Safety*)

Aspek ini memantau potensi risiko insiden klinis yang diakibatkan oleh proses pelayanan penunjang medik:

- a. Farmasi: Angka kejadian kesalahan pemberian obat yang mencakup fase penyiapan dan penyerahan, serta pemantauan obat mirip (*Look Alike Sound Alike / LASA*).
- b. Laboratorium (ATLM): Angka kesalahan identifikasi sampel laboratorium, kesalahan *input* hasil pemeriksaan, atau insiden sampel rusak/beku.
- c. Radiologi: Angka kejadian kesalahan pemotretan posisi anatomi pasien atau kesalahan pemberian label identitas pada hasil citra radiografi.
- d. Gizi: Angka kejadian kesalahan pemberian jenis diet makanan pada pasien rawat inap yang tidak sesuai dengan instruksi klinis dokter.
- e. Rekam Medis: Angka kesalahan identifikasi pasien pada saat pendaftaran atau penggabungan berkas rekam medis ganda (*duplikasi*).
- f. Fisioterapi: Angka kejadian pasien jatuh atau cedera jaringan lunak/sendai penyerta saat pelaksanaan tindakan terapi fisik atau mobilisasi.

2. Mutu Hasil Pelayanan dan Akurasi Klinis

Aspek ketepatan, validitas, dan kualitas teknis dari produk pelayanan yang dikeluarkan:

- a. Laboratorium: Persentase kepatuhan pelaksanaan Pemantauan Mutu Internal (PMI) dan Pemantauan Mutu Eksternal (PME) alat laboratorium.
- b. Radiologi: Angka penolakan hasil foto rontgen akibat kualitas gambar yang tidak layak baca.
- c. Rekam Medis: Angka keakuratan dan ketepatan pengkodean diagnosis penyakit (*Coding*) berdasarkan ICD-10 dan ICD-9-CM untuk klaim pelayanan.
- d. Gizi: Angka sisa makanan pasien rawat inap yang tidak termakan (sebagai indikator kesesuaian cita rasa dan kebutuhan asupan gizi pasien).
- e. Fisioterapi: Persentase kesesuaian pencapaian target pemulihan fungsional pasien pasca-stroke atau pasca-cedera dengan rencana program terapi awal.

3. Kecepatan Respons Pelayanan (*Response Time*)

Aspek efisiensi waktu tunggu pelayanan yang berdampak langsung pada kepuasan pasien:

- a. Farmasi: Waktu tunggu pelayanan obat jadi (maksimal 30 menit) dan obat racikan (maksimal 60 menit).
- b. Laboratorium: Waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium (*Turn Around Time*) untuk pemeriksaan laboratorium (maksimal 60 menit) dan untuk cito/darurat (maksimal 30 menit).
- c. Radiologi: Waktu tunggu hasil pelayanan foto rontgen thoraks cito/reguler.
- d. Rekam Medis: Kecepatan waktu penyediaan berkas rekam medis untuk pelayanan di poliklinik rawat jalan (maksimal 10 menit).

- e. Fisioterapi: Waktu tunggu dimulainya pelayanan terapi fisik sejak pasien mendaftar di unit fisioterapi rawat jalan (maksimal 15 menit).

4. Edukasi dan Komunikasi Efektif

Aspek pemberian informasi klinis profesional untuk menurunkan kecemasan dan meningkatkan pemahaman pasien:

- a. Farmasi: Pelaksanaan Pemberian Informasi Obat (PIO) dan konseling obat khusus kepada pasien/keluarga saat penyerahan obat pulang.
- b. Gizi: Pelaksanaan edukasi, konseling gizi, dan perencanaan diet terintegrasi bagi pasien rawat inap dengan penyakit komorbid/kronis.
- c. Radiologi & ATLM: Pemberian edukasi instruksi persiapan pra-tindakan (seperti instruksi puasa sebelum pemeriksaan laboratorium atau sebelum foto rontgen dengan kontras).
- d. Fisioterapi: Pemberian edukasi latihan fisik mandiri di rumah (*home program*) kepada pasien dan pendamping pasien sebelum menyelesaikan program terapi rawat jalan.

BAB X

PENUTUP

Pedoman ini menjadi acuan bagi seluruh anggota Komite Tenaga Kesehatan Lain dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, serta menjadi bagian dari bukti implementasi standar akreditasi rumah sakit.

Pasuruan, 1 Januari 2026

Direktur Rumah Sakit Prima Husada



Ns.Heni Indra Wulansari, S.Kep.,M.Kep

Ketua Komite Tenaga Kesehatan
Lain

A stylized handwritten signature in black ink, consisting of a large 'E' and 'U'.

Elza Safarina Ulfa, A.Md.AK